PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 157 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjd_surakarta@yahoo.com Website : http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 002.4 / 01 / 2020

TENTANG
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
b. bahwa Peta Proses Bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah;
c. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di RS. Jiwa Daerah Surakarta, dipandang perlu keberadaan Peta Proses Bisnis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Peta Proses Bisnis pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

'9. Peraturan Gubernur ..... (2)

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/434/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Penetapan Peta Proses Bisnis pada RS. Jiwa Daerah Surakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : SURAKARTA
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2020

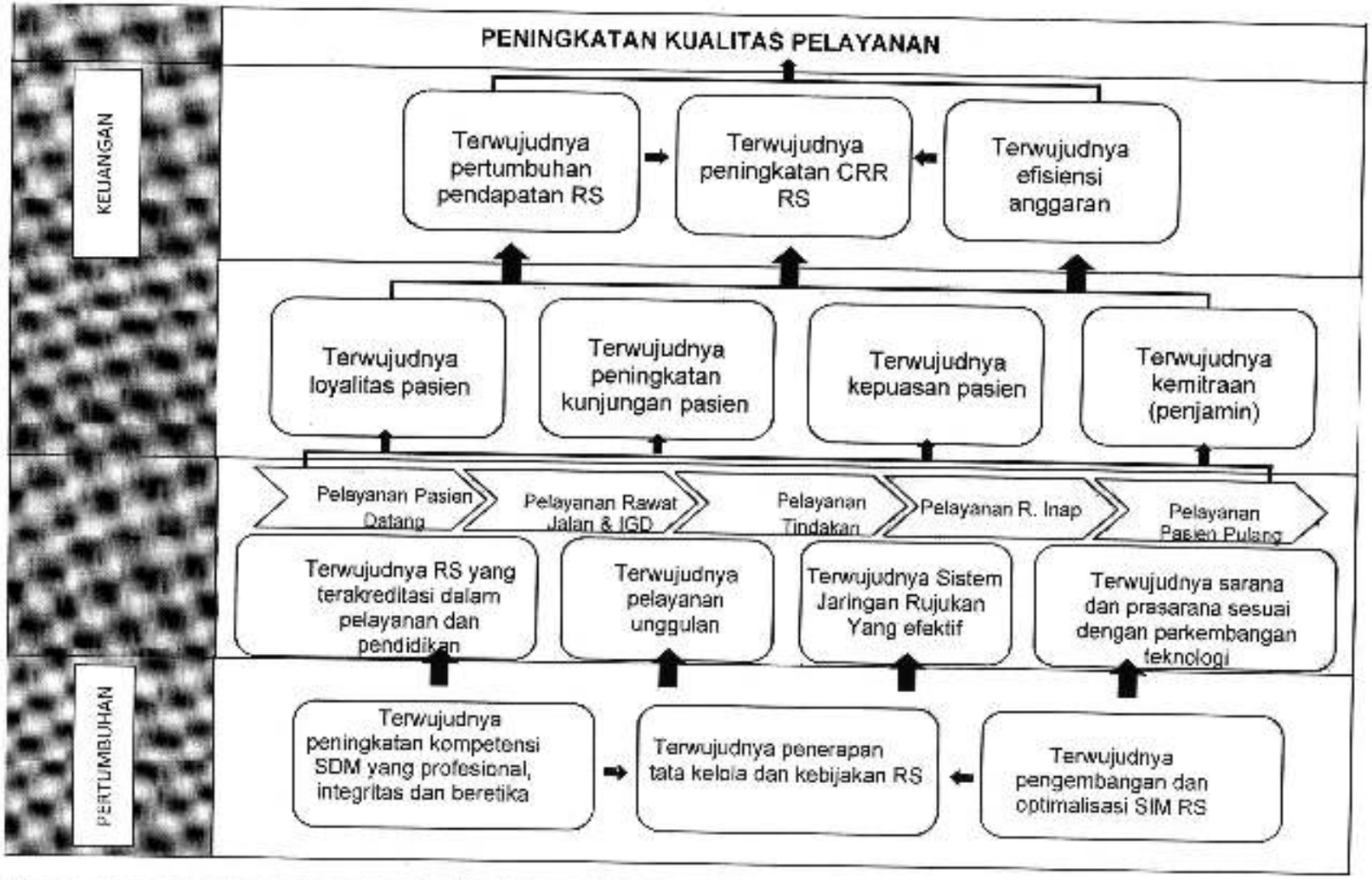
Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

ENDRO SUPRAYITNO

PETA PROSES BISNIS RS. JIWA DAERAH SURAKARTA

1. PETA PROSES BISNIS

A. Peta Proses Bisnis RS. Jiwa Daerah Surakarta



B. Value Chain RS. Jiwa Daerah Surakarta

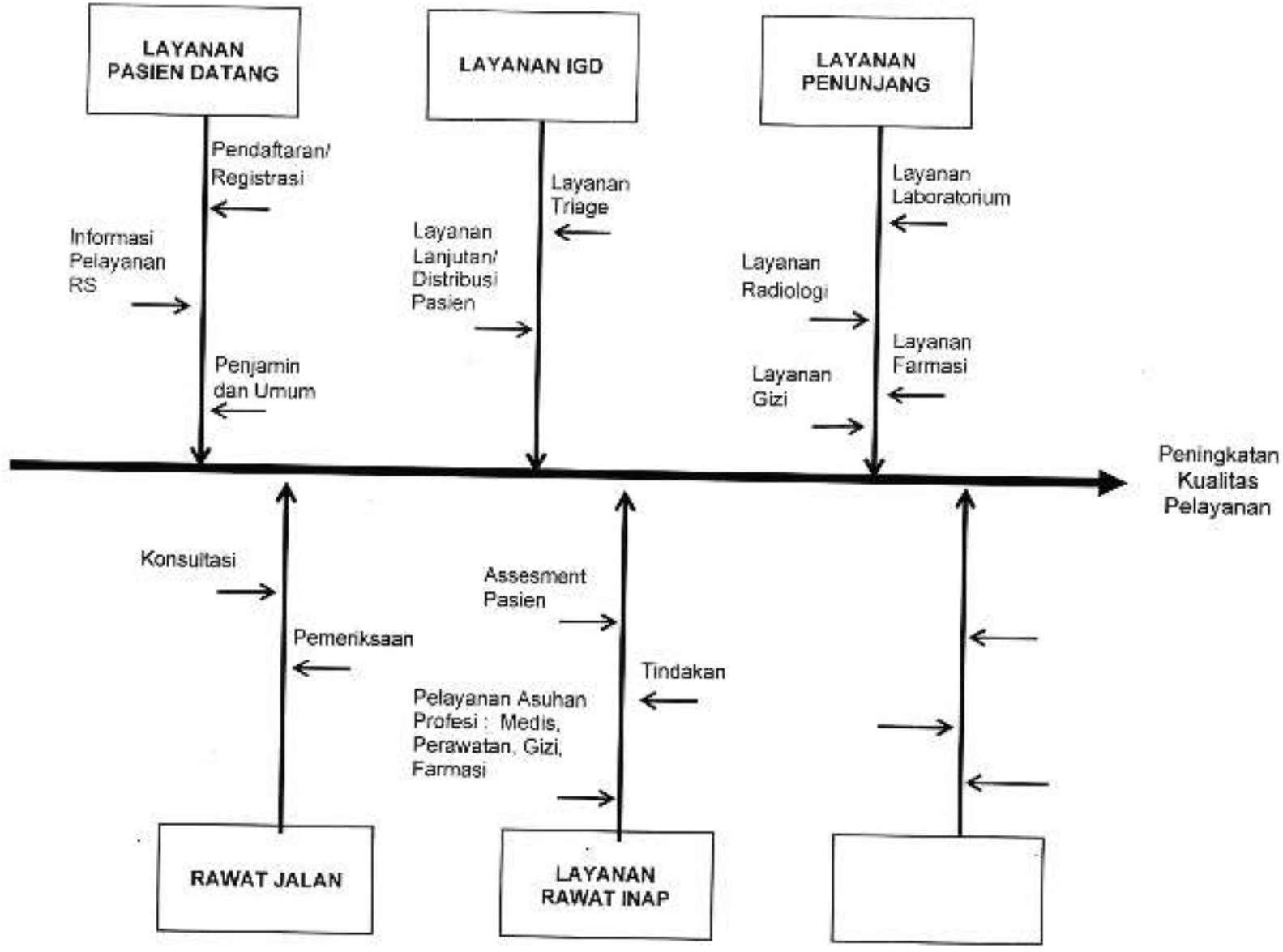
1) CORE PELAYANAN



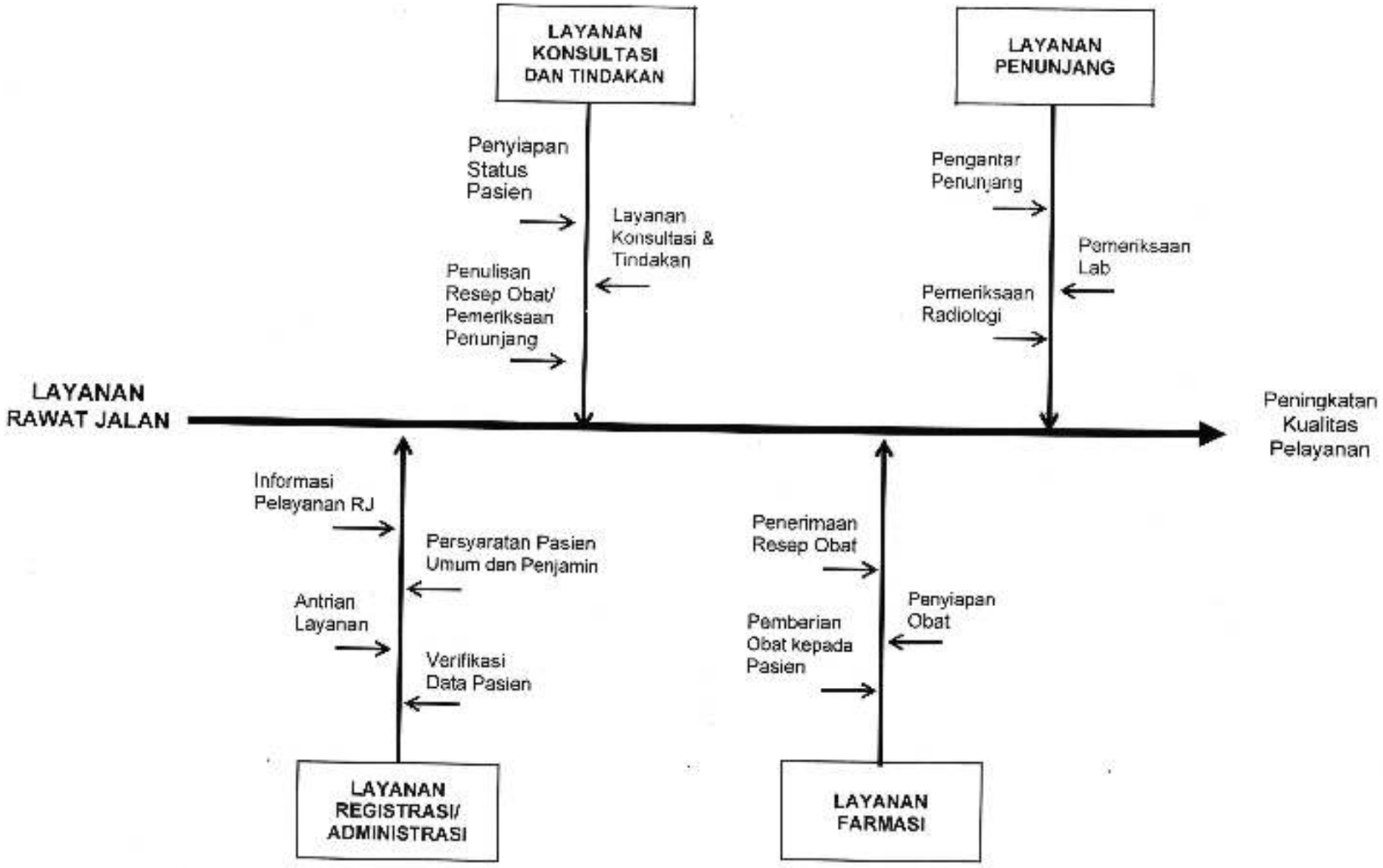
2) CORE PENDUKUNG

Dukungan Penunjang Medis : Laboratorium, Farmasi, Gizi, Radiologi, Fisioterapi, Elektromedik Gigi. **Dukungan Penunjang Non Medis :** IPRS,Laundry,Sanitasi,Tumbuh Kembang Anak,Rekam Medik
Dukungan Pendidikan, Perencanaan & Evaluasi : Diklitbang,PME & IT
Dukungan Umum & Kepegawaian : Kepegawaian, Rumah Tangga, Pemasaran, Humas, &Sarpras
Dukungan Akuntansi & Keuangan : Audit

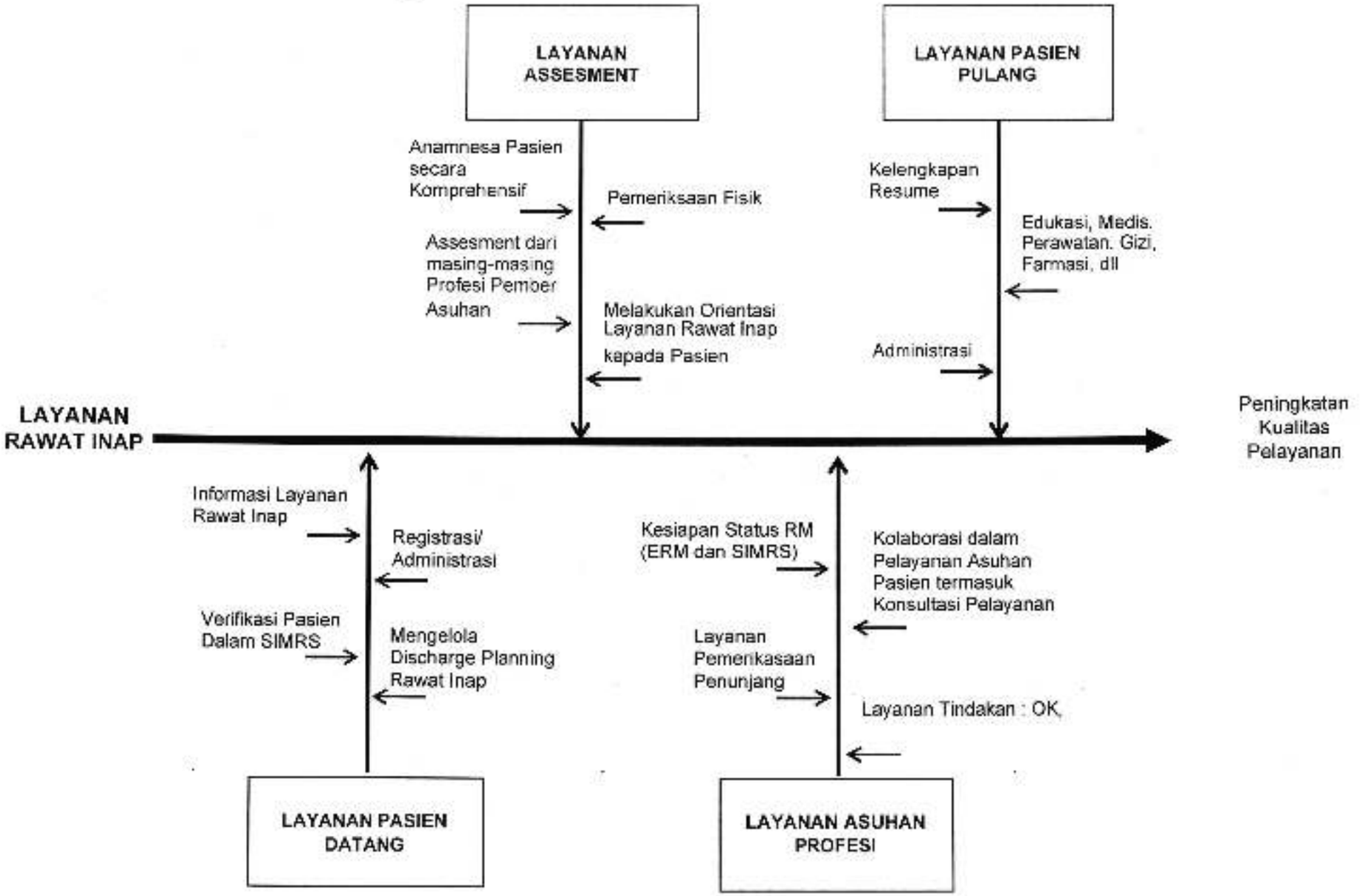
C. Proses Bisnis Utama



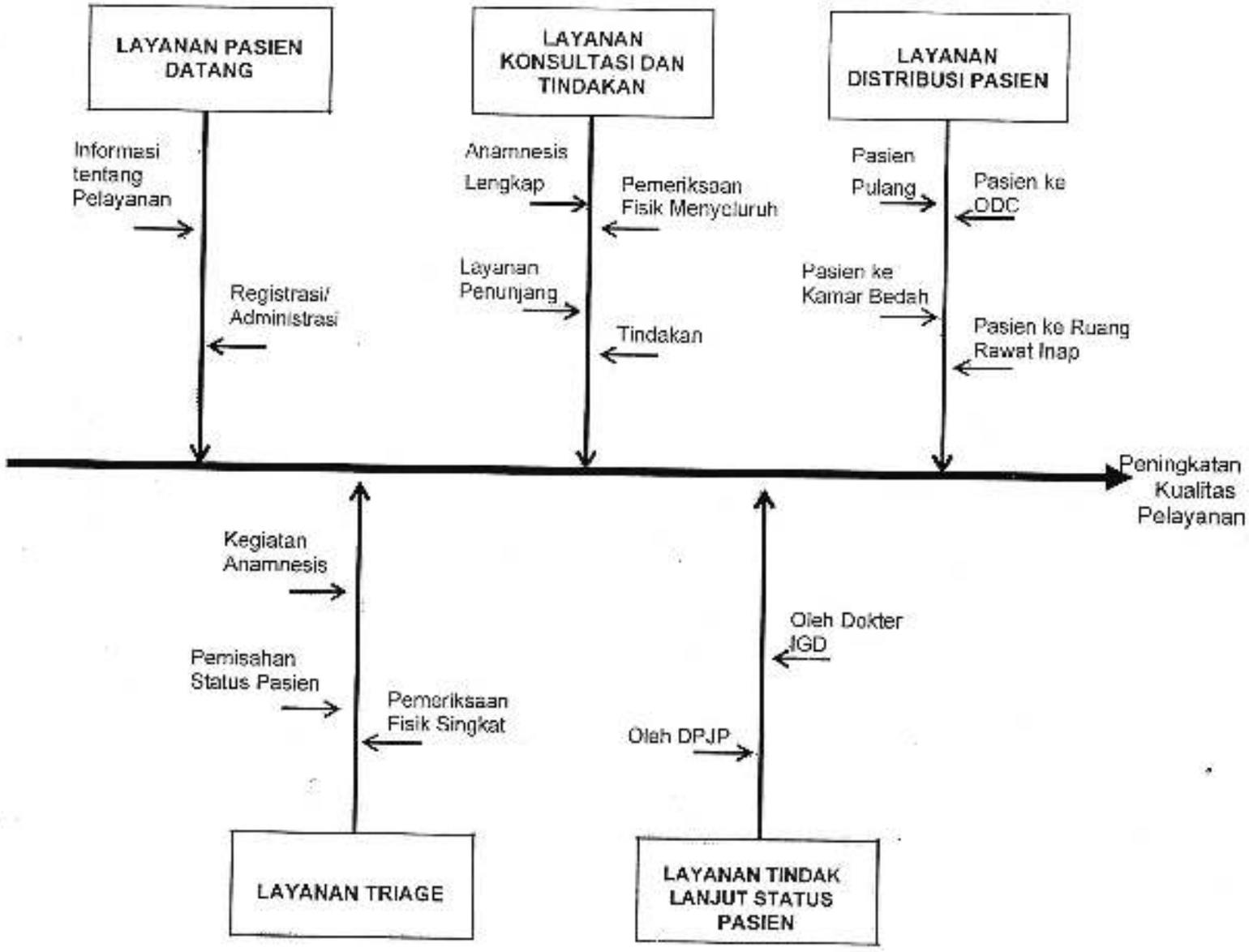
D. Proses Bisnis Rawat Jalan



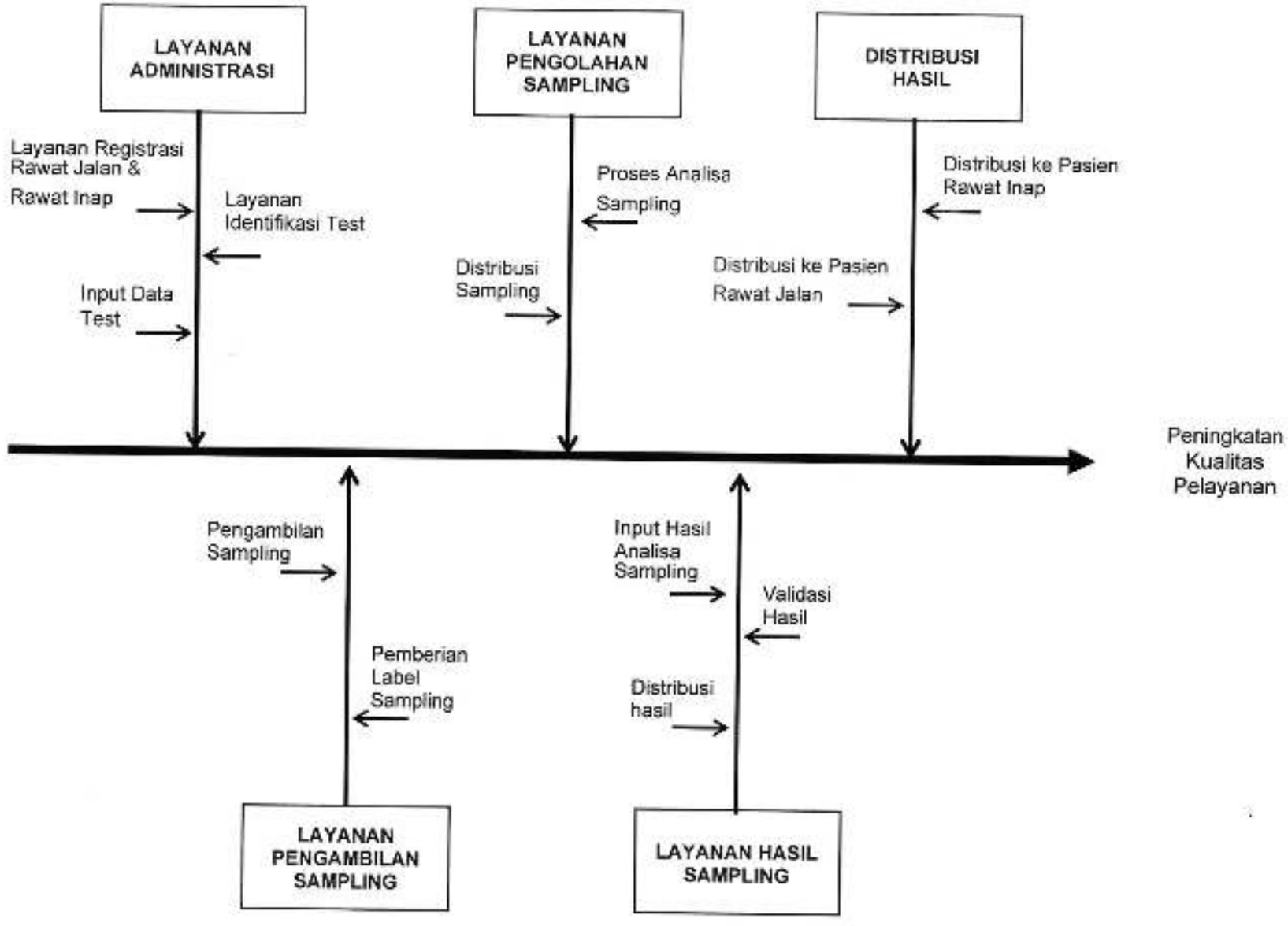
E. Proses Bisnis Rawat Inap



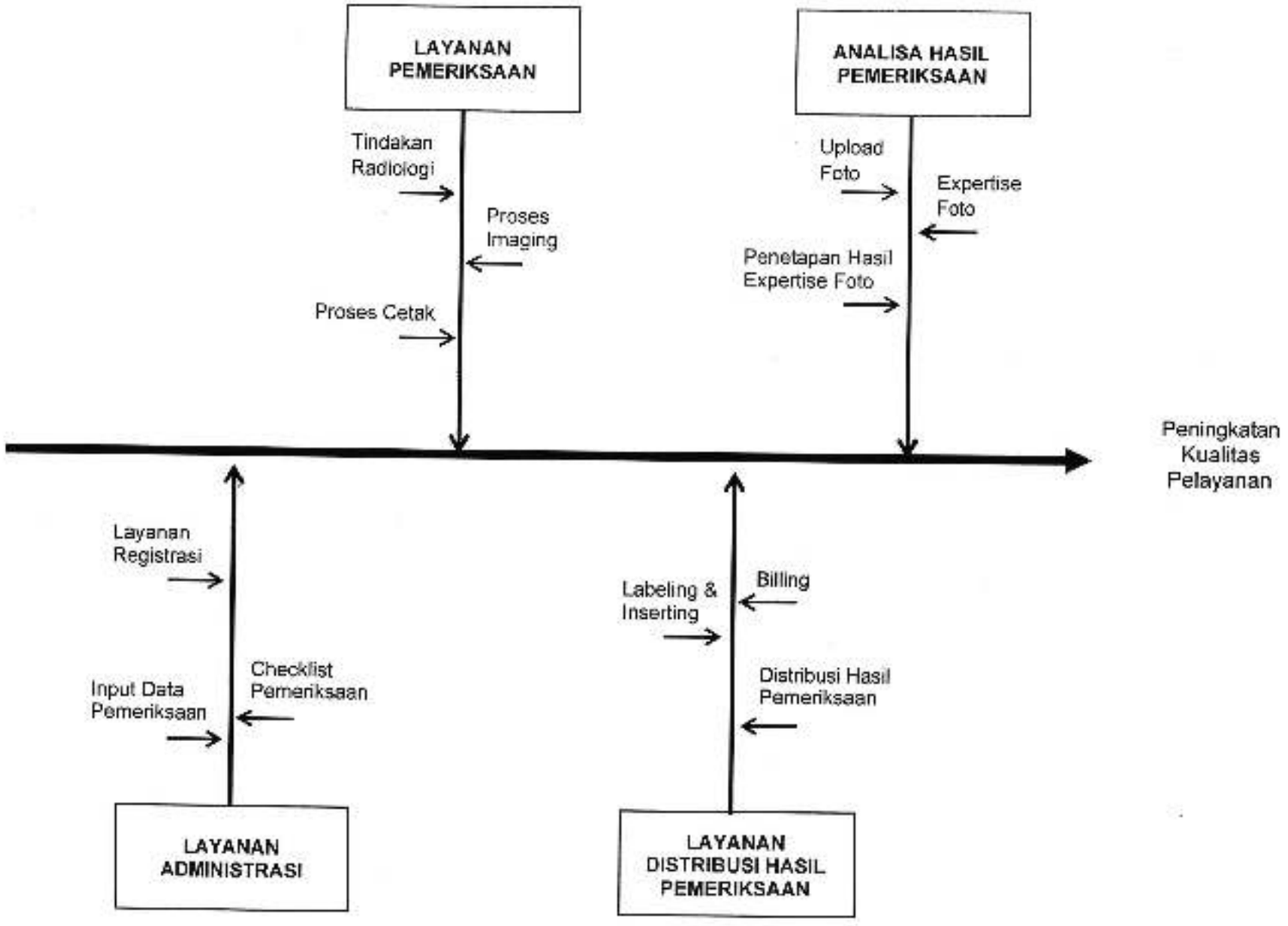
F. Proses Bisnis IGD



G. Proses Bisnis Laboratorium



H. Proses Bisnis Radiologi



2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

2.1 PELAYANAN RAWAT JALAN

A. Permasalahan/ Hambatan

1. Kedatangan Pasien : info pelayanan masih kurang
2. Registrasi : antrian pendaftaran, antrian verifikasi
3. Pemeriksaan/ Tindakan, Konsultasi : kesiapan status RM, layanan pemeriksaan/ konsultasi, layanan penunjang
4. Layanan Farmasi/ Obat : penerimaan resep, layanan obat, edukasi obat pasien belum optimal
5. Layanan administrasi : penjamin dan umum

B. Solusi/ Upaya Pemecahan Masalah

1. Kedatangan Pasien : disiapkan layanan informasi, media informasi (leaflet, papan informasi) tentang jenis layanan, jadwal pelayanan, nama dokter pemberi layanan
2. Registrasi dan layanan administrasi : disiapkan mesin antrian dan loket pelayanan yang untuk pasien umum dan penjamin, pasien kunjungan Baru dan kunjungan Lama/ Ulang, masih dalam proses pendaftaran via ON LINE
3. Pemeriksaan/ Tindakan, Konsultasi : disiapkan layanan aplikasi Rekam Medis Elektronik, Layanan pemeriksaan/ Konsultasi dan Penunjang yang terintegrasi dalam ERM.
4. Layanan Farmasi/ Obat : dipisahkan layanan farmasi Rawat Jalan dan Rawat Inap, mesin antrian untuk farmasi, layanan obat terintegrasi dengan ERM, Edukasi/ konsultasi cara pemberian Obat

2.2 PELAYANAN IGD

A. Permasalahan/ Hambatan

1. Kedatangan Pasien : info pelayanan masih kurang
2. Layanan Triage: anamnesa, pemeriksaan fisik cepat dan akurat, kesiapan status RM
3. Layanan Tindakan, Konsultasi: Kesiapan Status RM, layanan pemeriksaan/ konsultasi, Layanan penunjang, Tindakan cepat dan tepat

4. Layanan Distribusi Pasien: Informasi pasien Pulang, One day care, tindakan Cyto, Pasien Rawat Inap
5. Layanan Tindak lanjut: informasi Dokter Penanggung Jawab Pasien.

B. Solusi/ Upaya Pemecahan Masalah

1. Kedatangan Pasien: disiapkan layanan registasi Loket khusus IGD, pelayanan penjamin dan umum
2. Layanan Triage: tersedia layanan ERM yang memfasilitasi hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penetalaksanaan tindakan yang terintegrasi
3. Layanan Tindakan, Konsultasi: disiapkan layanan aplikasi Rekam Medis Elektronik, Layanan pemeriksaan/ Konsultasi dan Penunjang yang terintegrasi dalam ERM.
4. Layanan Distribusi Pasien: Edukasi yang jelas dan akurat segala informasi melalui persetujuan/ informed concern pasien/ keluarga baik pasien pulang, tindakan maupun rawat inap
5. Layanan TindakLanjut: informasi dan edukasi pada pasien tentang dokter penanggungjawab pasien dalam menerima layanan baik selama di IGD dan selama Rwat Inap atau Tindakan,

2.3 PELAYANAN RAWAT INAP

A. Permasalahan/ Hambatan

1. Kedatangan Pasien : info pelayananrawat inap masih kurang, fasilitas kamar pasien, administrasi/ registrasi rawat inap
2. Layanan assessment pasien : anamnesa, pemeriksaan fisik, assessment perawatan, medis dan gizi dalam rekam medis belum lengkap
3. Layanan asuhan dari profesi: Kesiapan Status RM, layanan profesi pemberi asuhan mulai dari medis, perawatan, gizi dan farmasi belum optimal
4. Layanan persiapan pasien Pulang: kelengkapan tentang resume medis dan tindak lanjut setelanh pasien keluar/ pulang dari rumah sakit

B. Solusi/ Upaya Pemecahan Masalah

1. Kedatangan Pasien: disiapkan informasi tentang rawat inap, kelas dan fasilitas rawat inap, tarif rawat inap dan tindakan melalui pusat informasi dan media. Disiapkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur (proses aplikasi SIRANAP/ system informasi rawat inap bekerjasama dengan BPJS dan Kemenkes)
2. Layanan Assesment Pasien: tersedia layanan ERM yang memfasilitasi hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penetalaksanaan tindakan yang terintegrasi dari semua profesi yang melakukan pengkajian.
3. Layanan Asuhan dari profesi: disiapkan layanan aplikasi Rekam Medis Elektronik, Layanan pemeriksaan/ Konsultasi dan Penunjang yang terintegrasi dalam ERM dari semua profesi pemberi asuhan baik medis, keperawatan, gizi dan pelayanan Farmasi.
4. Layanan Persiapan Pasien Pulang: informasi dan edukasi pada pasien tentang layanan setelah pulang sesuai resume medis, informasi persyaratan administrasi pulang, edukasi farmasi/ gizi waktu pulang.

2.4 PELAYANAN LABORATORIUM

A. Permasalahan/ Hambatan

1. Layanan Administrasi : system layanan rawat inap dan rawat jalan masih belum optimal masih melalui pengantar manual
2. Layanan pengambilan Sampling: layanan tindakan sampling dan labeling rawat inap dan rawat jalan belum optimal
3. Layanan Pengolahan Sampling: pemerksaan dan analisa sampling belum terintegrasi dengan rawat inap dan rawat jalan dalam SIMRS/ ERM.
4. Layanan hasil : validasi hasil dan distribusi hasil masih manual

B. Solusi/ Upaya Pemecahan Masalah

1. Layanan Administrasi : layanan administrasi melalui SIMRS yang terintegrasi dengan ERM
2. Layanan Pengambilan Sampling : layanan permintaaan sudah melalui ERM/ SIMRS, untuk pasien rawat inap ada petugas lab yang

3. mengambil sampling di ruang rawat inap. Sedangkan pasien rawat jalan dilayani sesuai jadwal.
4. Layanan pengolahan sampling: pemerksaan dan analisa sampling sudah terintegrasi dengan rawat inap dan rawat jalan dalam SIMRS/ ERM.
5. Layanan Layanan hasil: validasi hasil dan distribusi hasil sudah terintegrasi dengan rawat inap dan rawat jalan dalam SIMRS/ ERM.

2.5 PELAYANAN RADIOLOGI

A. Permasalahan/ Hambatan

1. Layanan Administrasi : system layanan rawat inap dan rawat jalan masih belum optimal masih melalui pengantar manual
2. Layanan Pemeriksaan: layanan tindakan, imaging dan cetak rawat inap dan rawat jalan belum optimal masih jadi satu
3. Layanan Analisa Hasil Pemeriksaan: pemerksaan (upload) Foto dan ekpertise foto masih manual
4. Layanan hasil: billing, labeling dan inserting masih manual ke masing masing pasien baik rawat inap maupun rawat jalan

B. Solusi/ Upaya Pemecahan Masalah

1. Layanan Administrasi : layanan administrasi melalui SIMRS yang terintegrasi dengan ERM
2. Layanan Pemeriksaan: layanan permintaaan sudah melalui ERM/ SIMRS, untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan dilayani sesuai jadwal dan jenis layanan/ pemeriksaan dalam aplikasi SIMRS/ ERM
3. Layanan Analisa Hasil Pemeriksaan: pemerksaan upload foto dan ekpertise foto terintegrasi antara mesin dan aplikasi ERM (Aplikasi dalam proses.
4. Layanan Layanan hasil: labeling dan inserting serta distribusi hasil sudah terintegrasi dengan rawat inap dan rawat jalan dalam SIMRS/ ERM namun juga disediakan hasil cetak manual.

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah

ENDRO SUPRAYITNO